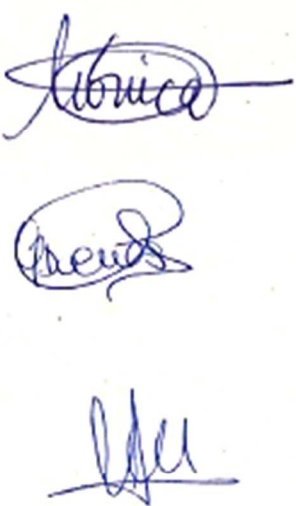


Procedimiento operativo estandarizado (POE) de

CUIDADOS POSTOPERATORIOS DEL PACIENTE QUIRÚRGICO

POE-ENF-A04-V2

Fecha entrada en vigor: 20 de enero 2025

FECHA	REALIZADO: Marzo 2024	REVISADO: Diciembre 2024	APROBADO: Enero de 2025
NOMBRE	Mónica Carrillo Ruiz Gema Dueñas Antúnez Angela Montoro Martínez	Sara Requejo Arranz	Rocío Segura Ruiz
CARGO	Enfermeras de UGC Cirugía Torácica	Supervisora de UGC Cirugía Torácica	Directora de Enfermería
FIRMA			
Responsable de revisión Sara Requejo Arranz			Fecha de revisión 2029
Lugar de archivo Dirección de enfermería			Responsable custodia Dirección de enfermería

1. OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto describir los cuidados de enfermería en el período postoperatorio de pacientes sometidos a una cirugía, permitiendo conseguir su recuperación temprana, identificando sus necesidades y garantizando una educación sanitaria adecuada. De esta forma, se puede prevenir y detectar la aparición de posibles complicaciones.

2. ALCANCE

Este POE es de aplicación para profesionales del Hospital Universitario Reina Sofía (HURS) y afecta a todo el personal implicado en la atención y cuidados del paciente y familia.

Si tiene dudas con la interpretación de esta versión o quiere hacer alguna mejora u observación, puede dirigirse a Sara Requejo Arranz de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Torácica, en el teléfono corporativo: 671594658 y correo electrónico: sara.requejo.sspa@juntadeandalucia.es.

3.- EQUIPAMIENTO NECESARIO

Para la acogida del paciente tras la cirugía:

- Tensiómetro
- Termómetro
- Pulsioxímetro
- Glucómetro
- Inspirón incentivador, si está indicado
- Toma de oxígeno
- Toma de vacío
- Para la realización de los cuestionarios de valoración:
 - o Acceso directo a estación de cuidados. <http://eedae.reinasofia.sas.junta-andalucia.es/HistoriaDeSaludHospitalizacionCuidados/>
- Para la retirada/cambio de drenaje y cura de herida quirúrgica:
 - o Jabón antiséptico de clorhexidina al 4% (higiene de manos)
 - o Guantes (estériles/no estériles)

- Suero fisiológico estéril
- Antiséptico (clorhexidina acuosa al 2%/ povidona yodada/ Prontosán^R solución² (cura de herida quirúrgica).
- Gasas estériles
- Paño estéril.
- Apósitos de gasa estériles
- Apósito transparente estéril para fijación de vía venosa central (Tegaderm^R).
- Otros materiales específicos según tipo de intervención

4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

4.1. Definición

Se identifica como **postoperatorio** al periodo de tiempo que transcurre a partir del momento de concluir una cirugía hasta que el paciente se recupera por completo.

El postoperatorio abarca tres fases:

- Post-operatorio inmediato (primeras 24 horas tras intervención quirúrgica y tiene lugar en la Unidad de Reanimación).
- Post-operatorio mediato (a partir de las 24 horas de la intervención y tiene lugar en la Unidad de Hospitalización).
- Post-operatorio tardío (tras el alta a domicilio y contempla las revisiones en Consultas Externas y el seguimiento en Atención Primaria).⁵

4.2. Descripción de la técnica

De manera general, después de la intervención quirúrgica se promoverá la movilización precoz (valorando la situación clínica individualizada de cada paciente), disminuyendo el dolor, el miedo y la ansiedad tras la cirugía. Se fomentará la independencia y seguridad del paciente de manera que colabore en su recuperación, consiguiendo así disminuir la tasa de infecciones quirúrgicas y complicaciones, conforme a las directrices de nuestro sistema público de salud, en relación con la infección quirúrgica ZERO, habiendo tenido en cuenta evidencias científicas recientes¹.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL POSTOPERATORIO INMEDIATO

Este escenario contempla los siguientes circuitos⁶:

- 1º.- Comprobar identificación del paciente de acuerdo con el [POE 011](#)

2º.- Valorar la situación del paciente a su llegada a la Unidad: toma y registro de constantes vitales, identificación y valoración de vías venosas, sondas y drenajes.

3º.- Colocar al paciente en la posición más adecuada en función del tipo de cirugía y las circunstancias específicas del/la paciente.

4º.- Valorar el estado de la herida quirúrgica: apósitos limpios.

5º.- Cuidados del sistema de drenaje, si lo hubiera:

- Colocar el sistema de drenaje en un lateral de la cama.
- Comprobar, si procede, que las conexiones del drenaje estén bien fijadas y sin esparadrapo que las selle para facilitar su vigilancia.
- Colocar aspiración a la unidad colectora, si precisa, según prescripción facultativa.
- Vigilar que las tubuladuras del drenaje no estén acodadas y comprobar su permeabilidad.
- Valoración del débito: observar y registrar el aspecto y la cantidad del drenado.

11º.- En caso de portar catéter epidural:

- valorar zona de inserción, conexión del filtro.
- Etiquetar el catéter para evitar confusiones.
- Asegurar que el paciente conoce el funcionamiento del dispositivo para analgesia a bolos.

12º.- Valorar permeabilidad, número y posición de vías venosas periféricas y centrales. Si llega con varias vías venosas periféricas dejar la más adecuada y retirar el resto.

13º.- En caso de sonda vesical, se valorará si es necesario mantenerla o se procede a la retirada (comprobar indicaciones del facultativo y normativa propia de la UGC). Si se mantuviera, comprobar permeabilidad y colocar la bolsa de diuresis en un lateral de la cama.

14º.- Realizar el cuestionario de listado de verificación postquirúrgica (anexo 01).

15º.- Realizar el cuestionario de seguimiento y monitorización de catéteres venosos periféricos y centrales (anexo 02).

16º.- Valorar el grado de dolor con el que llega el paciente mediante la escala EVA (Valoración Analógica del Dolor). (Anexo 03).

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL POSTOPERATORIO MEDIATO

Control de las constantes vitales

- Tomar presión arterial y frecuencia cardíaca con una frecuencia que dependerá del estado del paciente y del protocolo de toma de constantes que exista en la Unidad.
- Control de pulsioximetría, temperatura y dolor mediante escala EVA.
- En caso de pacientes diabéticos, realizar glucemia capilar basal y corrección según pauta de insulina.
- Registro de constantes en módulo de cuidados Diraya.

Control de la herida quirúrgica

- Realizar cura según protocolo de la unidad. En caso de duda, consultar el Procedimiento de Enfermería B11: Cuidado de las heridas quirúrgicas.
- Si presenta serosidad, recoger muestra para cultivo e informar al facultativo.
- Retirada de agujas según protocolo de la unidad.
- En caso de supuración y/o infección o acumulación de seroma, tomar muestra para cultivo y antibiograma e informar al facultativo.
- Si el apósito está manchado, valorar el cambio de apósito para evitar la maceración de la piel.

Control de los drenajes

- Comprobar y apretar las conexiones en cada turno.
- Vigilar que el tubo del drenaje y las tubuladuras no estén acodadas.
- Valorar el débito (cantidad y aspecto del líquido drenado), anotar la cantidad de débito en gráfico.
- Si se coloca aspiración al drenaje, se verificará por turno que exista un burbujeo constante y moderado o la intensidad de la aspiración.
- Valorar otros cuidados específicos según tipo de drenaje, por ejemplo, cuidados del drenaje pleural.
- Retirada del drenaje cuando esté indicado:
 - Informar al paciente.
 - Reunir el material y equipo necesario: guantes estériles, gasas, antiséptico, paño estéril, apósitos y hojas de bisturí.
 - Si el drenaje es activo, eliminar el vacío para que se detenga la succión.
 - Retirar los apósitos que cubren el tubo de drenaje.
 - Retirar la sutura que mantiene el drenaje unido a la piel.
 - Retirar el drenaje con suavidad.

- Tapar el orificio del drenaje con un apósito.
- Durante las primeras horas tras la retirada del drenaje, revisar la zona donde se encuentra el apósito para detectar sangrado abundante, si lo hubiera.

Otros cuidados específicos según la cirugía

Algunas cirugías requieren cuidados específicos, por ejemplo, vigilancia de la función respiratoria en el caso de la cirugía torácica. Consultar los documentos de referencia específicos de la unidad.

Control de los accesos venosos y fluidos

- Se tiende a la retirada precoz de los sueros tras asegurarse que el paciente tiene una buena tolerancia gástrica a la alimentación oral.
- Tras su retirada, la vía venosa quedará salinizada o heparinizada según protocolo de la unidad para la administración de medicación endovenosa si fuera necesario.

Control del dolor

- Administrar la analgesia prescrita y valorar su eficacia mediante la escala EVA.
- Explicar al paciente la importancia que tiene el hecho de que mantenga niveles de analgesia adecuados para la movilización precoz y los ejercicios de fisioterapia indicados según intervención.
- Instruir al paciente para que adopte posturas antiálgicas.
- En caso de analgesia a través de catéter epidural:
 - Controlar las conexiones y la bomba de infusión si la hubiera.
 - Realizar cura estéril diaria de la zona de inserción del catéter.
 - Vigilar si aparece cefalea, vómitos, distensión abdominal o retención urinaria.
 - Tener en cuenta que para la retirada del catéter epidural han tenido que transcurrir 12 horas desde la última dosis de anticoagulación y no poner la siguiente dosis antes de las 4 horas de su retirada.

Control del sondaje vesical

- Si no existe contraindicación, se intentará retirar la sonda vesical en las primeras 24 horas. Se anotará la diuresis existente y se vigilará la micción espontánea.
- Se controlará el volumen total de orina cada 24 horas.
- Vigilar si aparece disuria, escozor, orina turbia.

Control de la movilidad

- Debe ser progresiva pero precoz y en función de la intervención quirúrgica realizada. De ahí, la necesidad de controlar bien el dolor.
- Siempre que sea posible y esté indicado, insistir al paciente para que se levante a la silla, que deambule si puede para evitar complicaciones.

Control de la dieta

- Instaurar una dieta de tolerancia progresiva si no hay contraindicación médica hasta llegar a la dieta habitual del paciente.
- Vigilar la aparición de náuseas, vómitos y distensión abdominal.

4.3. Segregación de residuos.

Tras inserción y/o retirada de drenajes torácicos se procederá a realizar la siguiente segregación de residuos:

- Clase II: Residuos sanitarios asimilables a urbanos
 - Material de cura, gasas y apósitos.
 - Jeringas sin agujas
 - Guantes
 - Algodones y papel manchados de sangre.
- Clase IIIa: Residuos Sanitarios Especiales.
 - **Contenedor amarillo:** cualquier objeto cortante y/o punzante utilizado en laboratorios y que haya estado en contacto con fluidos corporales (agujas, lancetas y hojas de bisturí)
 - **Contenedor verde:** residuos infecciosos no cortantes ni punzantes, residuos sólidos procedentes de cultivos de agentes biológicos. (Anexo 04)

Más información en la página Web Hospital Universitario Reina Sofía: Área de Servicios Generales: ¿Qué debo hacer si tengo que segregar [RESIDUOS SANITARIOS](#)

5. BIBLIOGRAFIA

1. Infecciónquirurgicazero.es. Sociedad Española de Medicina Preventiva. Salud Pública e Higiene; 2013, actualizado en 2016. Proyecto Infección Quirúrgica Zero. Disponible en: <http://www.infeccionquirurgicazero.es>
2. Prontosan^R Solución. <https://www.bbraun.es/es/products/b/prontosan-solucion.html>
3. Sistema de supervisión y drenaje torácico digital Thopaz⁺. <https://www.medelahealthcare.com/es-ES/solutions/chest-drainage/thopaz>
4. Aldaghlawi F, Kurman JS, Lilly JA, Hogarth DK, Donington J, Ferguson MK, Murgu SD. A Systematic Review of Digital vs Analog Drainage for Air Leak After Surgical Resection or Spontaneous Pneumothorax. Chest. 2020 Jan 17. pii: S0012-3692(20)30029-5.
5. Martínez Serrano, R; Molina Vega, M.D.P.; García Latasa de Aranibar, B; Baquedano García S. PE-14- La temida cirugía torácica, acercando a la enfermería. CIR ESP. 2021;99(Espec Congr 1):70.
6. Jiménez, M.F.; Martínez de Zúñiga, C. Manual SEPAR de Procedimientos.
7. Castelino T, Fiore JF Jr, Niculiseanu P et al The effect of early mobilization protocols on postoperative outcomes following abdominal and thoracic surgery: a systematic review. Surgery. 2016; 159:991- 1003.
8. Grupo de trabajo. Vía Clínica de Recuperación intensificada en Cirugía del Adulto (RICA). Vía clínica de recuperación intensificada en cirugía abdominal (RICA) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. 2021. Disponible en: <https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2021/05/via-clinica-cirugia-adulto-rica-2021.pdf>.

6. LISTADO DE DOCUMENTOS ASOCIADOS

- ANEXO 1: Cuestionario de listado de verificación postquirúrgica
- ANEXO 2: Cuestionario de seguimiento y monitorización de catéteres venosos periféricos y centrales.
- ANEXO 3: Cuestionario escala EVA
- ANEXO 4: Segregación de residuos.

7. LISTADO DE DISTRIBUCIÓN

Este procedimiento se puede consultar en la web del hospital <http://hrs3.hrs.sas.junta-andalucia.es/index.php?id=procedimientos>

Y se ha remitido por correo electrónico a:

NOMBRE Y APELLIDOS	SERVICIO / UNIDAD	FECHA
Francisco de Asís Triviño Tarradas	Director Gerente	Enero de 2025
Elena García Martínez	Directora Médica	Enero de 2025
Rocío Segura Ruiz	Directora de Enfermería	Enero de 2025
Amparo Simón Valero	Directora Económico - Administrativa	Enero de 2025
José Luís Gómez de Hita	Director de Servicios Generales	Enero de 2025
Juan Alfonso Sereno Copado	Director de Personal	Enero de 2025
Cargos intermedios dependientes de la Dirección de Enfermería		Enero de 2025

ANEXO 1- CUESTIONARIO DE LISTADO DE VERIFICACIÓN POSTQUIRÚRGICA

HOSPITALIZACION-VERIFICACION CUIDADOS POSTQUIRURGICOS

1. Identificación del paciente (pulsera) ☐ Si ☐ No	2. Pedida a Admisión (pulsera) ☐ Si ☐ No
3. Comprobación Hist. Clínica ☐ Si ☐ No	4. Via venosa central ☐ Si ☐ No
5. Via venosa periférica ☐ Si ☐ No	6. Alargadera ☐ Si ☐ No
7. Sonda nasogástrica ☐ Si ☐ No	8. Sonda vesical ☐ Si ☐ No
9. Catéter epidural ☐ Si ☐ No	10. Analgesia control UDA ☐ Si ☐ No
11. Drenaje: ☐ Penrose ☐ Redón/Blake ☐ Sin drenaje ☐ Otros	12. Aposito quirúrgico: ☐ Limpio ☐ Manchado ☐ Compresivo
13. Nivel de conciencia: ☐ Despierto ☐ Dormido	14. Higiene del paciente ☐ Adecuada ☐ Inadecuada

ANEXO 2- CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN DE CATÉTERES VENOSOS PERIFÉRICOS Y CENTRALES.

Manejo punto de punción y sistema de infusión

1. Tipo de apósito: Cambio.

☐ Apósito transparente

☐ Apósito transparente impregnado en antiséptico.

☐ Gasas o apósito opaco

2. Limpieza punto de punción

☐ Clorhexidina acuosa 2%

☐ Clorhexidina alcohólica 2%

☐ Povidona yodada

☐ Alcohol al 70%

☐ Otros

☐ Clorhexidina alcohólica 0,5 %

3. ¿Se ha cambiado sistema de infusión?

☐ Si

☐ No

Valoración punto de punción

1. Escala Visual de Valoración de Flebitis

☐ Grado 0. Sin síntomas

☐ Grado 1. Zona de punción sensible/dolorosa sin eritema, ni edema, ni cordón palpable.

☐ Grado 2. Zona de punción dolorosa con eritema y/o edema sin cordón palpable.

☐ Grado 3. Zona de punción dolorosa con eritema, edema, endurecimiento o cordón venoso palpable menor de 6 cm por encima del sitio de inserción.

☐ Grado 4. Zona de punción sensible con eritema, edema, endurecimiento, cordón venoso palpable mayor de 6 cm por encima del sitio de inserción y/o secreción purulenta.

☐ Grado 5. Trombosis venosa franca con todos los signos anteriores y dificultad o detención de la perfusión.

Acceso venoso: Tipo

1. Tipo de vía

☐ Catéter periférico corto

☐ Línea media.

☐ PICC

☐ CICC

☐ FICC

☐ Catéter tunelizado

2. Localización de la vía

☐ Yugular

☐ Subclavia

☐ Cefálica/Basilica

☐ Femoral

☐ Umbilical

☐ Otra

ANEXO 3- CUESTIONARIO ESCALA EVA

EVA

1. Indique el nivel de dolor

- ☐ 0 (Escala de rostros: Rostro muy contento)
- ☐ 1
- ☐ 2 (Escala de rostros: siente sólo un poquito de dolor)
- ☐ 3
- ☐ 4 (Escala de rostros: siente un poco más de dolor)
- ☐ 5
- ☐ 6 (Escala de rostros: siente aún más dolor)
- ☐ 7
- ☐ 8 (Escala de rostros: siente mucho dolor)
- ☐ 9
- ☐ 10 (Escala de rostros: el dolor es el peor que pueda imaginarse)

ANEXO 4- SEGREGACIÓN DE RESIDUOS.

CLASE I	CLASE II	CLASE IIIa	CLASE IIIb
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	RESIDUOS SANITARIOS ASIMILABLES A URBANOS	RESIDUOS SANITARIOS ESPECIALES	RESIDUOS QUÍMICOS Y OTROS.
 ❖ Cartón,papel,embalajes,..(Contenedor tapa azul) ❖ Papel de secarse las manos ,restos de comida,..(Papelería orgánica) ❖ Plásticos, latas, briks,.. (Contenedor tapa amarilla,..)	 • Material de curas, gasas y apósitos. • Bolsas o frascos de orina vacíos. • Jeringas sin agujas. • Guantes. • Algodones y papel manchados de sangre. • Puntas de pipeta no manchadas de sangre. • Papel de filtro utilizado para proteger las mesas. • Material de vidrio de laboratorio roto que no este contaminado. • Todo material que habiendo estado contaminado se haya tratado específicamente para su descontaminación y/o esterilización(Autoclave)	 CONTENEDOR AMARILLO (Cualquier objeto cortante y/o punzante utilizado en los laboratorios y haya estado en contacto con fluidos corporales.) • Agujas y lancetas • Pipetas, hojas de bisturí, portaobjetos, cubreobjetos, tubos capilares, palomillas ,tubos de vidrio rotos ,.... CONTENEDOR VERDE. • Residuos infecciosos no cortantes ni punzantes (puntas de pipeta, asas de siembra,...) • Residuos sólidos procedentes de cultivos de agentes biológicos(Placas Petri, tubos de ensayo, matraces,...) • Sangre y hemoderivados en forma líquida u otros líquidos biológicos.	 • Residuos de productos de laboratorio (envases, reactivos,...) • Envases de productos químicos peligrosos.  • Soluciones acuosas que contienen sustancias peligrosas, generadas por los analizadores y colorantes de tinciones que se realizan en bandejas.